

Tratamiento farmacológico y cognitivo-conductual

1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos de ansiedad** son los **más prevalentes** entre los trastornos psiquiátricos, afectando hasta un **15–20% de la población chilena** en algún momento de la vida. Comprenden entidades como el **trastorno de ansiedad generalizada (TAG)**, **trastorno de pánico**, **fobias**, **trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)** y **trastorno de estrés postraumático (TEPT)**.

El **tratamiento eficaz y oportuno** es esencial para evitar la cronificación, las comorbilidades (depresión, abuso de sustancias, somatización) y la discapacidad funcional.

Los pilares del manejo son **la farmacoterapia** y **la terapia cognitivo-conductual (TCC)**, que actúan de manera complementaria:

- Los **fármacos** alivian síntomas fisiológicos y cognitivos, facilitando la adherencia.
- La **TCC** corrige los patrones de pensamiento disfuncionales y previene recaídas.

En Chile, el **MINSAL** recomienda un abordaje **escalonado e integral**, centrado en la atención primaria, con derivación a salud mental solo en casos complejos o refractarios.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Bases neurobiológicas

Los trastornos de ansiedad comparten una **hiperactividad del sistema límbico**, especialmente de la **amígdala**, junto con una **disminución del control inhibitorio cortical** (corteza prefrontal medial).

Esto genera una respuesta exagerada ante estímulos neutros o amenazantes.

Principales neurotransmisores involucrados:

- **Serotonina (5-HT):** su déficit se asocia a ansiedad, obsesiones y rumiación.
- **GABA:** el principal neurotransmisor inhibitorio; su disfunción genera hiperexcitabilidad neuronal.

- **Noradrenalina:** hiperactividad del locus coeruleus → síntomas somáticos (taquicardia, temblor, sudoración).
- **Cortisol:** la activación crónica del eje hipotalámico-hipofiso-adrenal contribuye a la fatiga y vulnerabilidad emocional.

2.2. Modelos psicológicos

La **TCC** se sustenta en modelos cognitivos de Beck y Clark:

- La ansiedad surge de **distorsiones cognitivas** (catastrofismo, sobregeneralización, pensamiento dicotómico).
- Estas distorsiones alimentan un **círculo de evitación y miedo** que perpetúa el trastorno.

Por tanto, el tratamiento busca **modificar la interpretación de las amenazas** y **exponer gradualmente al paciente a los estímulos temidos** para generar habituación.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El tratamiento debe adaptarse al **tipo de trastorno de ansiedad**, aunque los principios generales son comunes.

Trastorno	Síntomas predominantes	Enfoque terapéutico
TAG	Preocupación excesiva y persistente, tensión muscular, insomnio.	ISRS + TCC centrada en control de preocupaciones.
Trastorno de pánico	Crisis súbitas con síntomas autonómicos y miedo a morir/enloquecer.	ISRS + TCC con exposición interoceptiva.
Fobias	Miedo irracional a objetos o situaciones específicas.	TCC con exposición progresiva.

TOC	Obsesiones y compulsiones repetitivas.	ISRS en dosis altas + TCC con prevención de respuesta.
TEPT	Reexperimentación, evitación, hiperactivación.	TCC focalizada en trauma + ISRS.

Diagnóstico diferencial:

- Depresión con ansiedad (predomina ánimo bajo).
- Hipertiroidismo, feocromocitoma o hipoglucemia (síntomas físicos).
- Abstinencia de benzodiazepinas, alcohol o cafeína.
- Esquizofrenia o psicosis (pérdida del juicio de realidad).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Antes de iniciar farmacoterapia:

- **Examen físico y signos vitales.**
- **Laboratorios básicos:** hemograma, TSH, glicemia, función renal y hepática.
- **ECG** si se considerarán tricíclicos o ISRS con riesgo de QT prolongado.
- **Evaluación psiquiátrica estructurada** (GAD-7, PHQ-9, HADS, Y-BOCS, CAPS-5 según el caso).

La ansiedad secundaria a causa médica o tóxica debe descartarse antes del tratamiento psiquiátrico.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile y evidencia actual)

El tratamiento se basa en **dos pilares sinérgicos**:

- A. **Farmacoterapia**, para aliviar síntomas fisiológicos y cognitivos.
 - B. **Terapia cognitivo-conductual**, para modificar pensamientos disfuncionales y prevenir recaídas.
-

A. Tratamiento farmacológico

1. Antidepresivos (primera línea)

Los **inhibidores selectivos de recaptura de serotonina (ISRS)** son el **tratamiento farmacológico de elección** en la mayoría de los trastornos de ansiedad.

Fármaco	Dosis inicial	Dosis terapéutica	Comentarios
Sertralina	25–50 mg/día	100–200 mg/día	Bien tolerada, segura en ancianos y embarazo.
Escitalopram	5–10 mg/día	10–20 mg/día	Excelente perfil de efectos secundarios.
Paroxetina	10–20 mg/día	20–50 mg/día	Sedante; riesgo de aumento de peso y abstinencia.
Fluoxetina	10–20 mg/día	20–60 mg/día	Activadora; útil si hay fatiga o depresión concomitante.
Citalopram	10 mg/día	20–40 mg/día	Riesgo de QT largo a altas dosis (>40 mg).

Tiempo de respuesta: 2–4 semanas; máxima eficacia en 8–12 semanas.

Duración: mantener **12 meses** tras la remisión; reducir gradualmente.

MINSAL Chile (Guía de Depresión y Ansiedad, 2022) recomienda iniciar ISRS en APS y continuar seguimiento conjunto con salud mental.

2. ISRN (segunda línea)

- **Venlafaxina (37.5–225 mg/día):** útil en TAG, pánico y TEPT.
 - **Duloxetina (30–120 mg/día):** alternativa con menor impacto sexual.
-

3. Benzodiacepinas (uso limitado y breve)

Fármacos ansiolíticos de acción rápida, **solo para manejo inicial (2–4 semanas)** o crisis agudas, **nunca en monoterapia**.

Fármaco	Dosis habitual	Vida media	Comentarios
Lorazepam	0.5–2 mg c/12 h	10–16 h	Opción segura en ancianos.
Clonazepam	0.25–1 mg c/12 h	20–40 h	Mayor riesgo de dependencia.
Alprazolam	0.25–0.5 mg c/8 h	8–12 h	Riesgo alto de abstinencia y abuso.

Evitar en: historia de adicciones, embarazo, apnea del sueño o uso crónico de alcohol.

Taper gradual (reducción del 10–25% semanal) al suspender.

4. Otros fármacos

- **Buspirona (15–60 mg/día):** útil en TAG leve o intolerancia a ISRS; sin dependencia.
 - **Pregabalina (150–600 mg/día):** alternativa en TAG resistente.
 - **Beta-bloqueadores (propranolol 10–40 mg):** para síntomas físicos situacionales (fobia social, performance).
 - **Antipsicóticos atípicos (quetiapina, risperidona):** solo en casos refractarios o comórbidos con TOC o TEPT.
-

B. Terapia cognitivo-conductual (TCC)

La **TCC** es la **terapia psicológica con mayor evidencia científica** para los trastornos de ansiedad.

Actúa modificando los **pensamientos automáticos**, las **creencias disfuncionales** y las **conductas de evitación** que mantienen el cuadro.

1. Componentes esenciales

1. **Psicoeducación:** explicar el modelo cognitivo de la ansiedad.
2. **Entrenamiento en respiración y relajación:** respiración diafragmática, relajación muscular progresiva de Jacobson.
3. **Exposición gradual:** enfrentamiento progresivo a los estímulos temidos (in vivo o imaginario).
4. **Reestructuración cognitiva:** identificar y reemplazar pensamientos catastróficos.
5. **Prevención de recaídas:** plan de mantenimiento y detección de señales tempranas.

2. Aplicaciones específicas

Trastorno	Enfoque TCC principal
TAG	Control de preocupaciones, exposición a pensamientos temidos, técnicas de mindfulness.
Trastorno de pánico	Exposición interoceptiva (recrear síntomas físicos) y reatribución cognitiva.
Fobia específica/social	Exposición progresiva + reestructuración de creencias de evaluación negativa.
TOC	Exposición con prevención de respuesta (EPR).
TEPT	Exposición narrativa al trauma + técnicas de grounding.

Duración promedio: **12 a 20 sesiones semanales**, combinadas con ejercicios domiciliarios.

5.3. Intervención combinada

La combinación de **ISRS + TCC** ofrece la **mayor eficacia terapéutica** y **menor tasa de recaídas**, especialmente en:

- Ansiedad generalizada severa.
- Trastorno de pánico con agorafobia.
- TEPT moderado a grave.
- TOC resistente.

La combinación se justifica cuando el paciente presenta alta carga somática, depresión comórbida o resistencia a monoterapia.

5.4. Consideraciones especiales

- **Niños/adolescentes:** preferir TCC; usar ISRS (sertralina o fluoxetina) solo si hay deterioro funcional grave.
 - **Embarazo:** sertralina es el antidepresivo más seguro; evitar paroxetina y BZD.
 - **Adulto mayor:** ajustar dosis a la mitad; evitar benzodiacepinas prolongadas.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- Cronificación o recaída si el tratamiento se suspende precozmente.
- Dependencia a benzodiacepinas.
- Disfunción sexual o ganancia de peso con ISRS (controlable).
- Reacción ansiosa inicial (“activación”) con ISRS, autolimitada.

Pronóstico

- Con tratamiento adecuado, **70–80%** de los pacientes presentan remisión o mejoría significativa.
 - La **TCC** reduce recaídas incluso tras suspensión del fármaco.
 - Factores de mal pronóstico: inicio precoz, comorbilidad depresiva, abuso de sustancias, pobre adherencia o personalidad ansiosa.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. Los **ISRS son primera línea** en casi todos los trastornos de ansiedad; requieren 4–6 semanas para actuar.
 2. **TCC y exposición** son más efectivas que la farmacoterapia sola a largo plazo.
 3. **Evita benzodiacepinas crónicas**: máximo 2–4 semanas.
 4. En **ansiedad con insomnio predominante**, puede usarse **quetiapina 25–50 mg nocturna** como coadyuvante.
 5. **Sertralina** es el ISRS más seguro en embarazo y lactancia.
 6. **Psicoeducar**: explicar que los síntomas iniciales pueden aumentar brevemente antes de mejorar.
 7. En pacientes con **trastornos cardíacos o QT prolongado**, preferir **sertralina o escitalopram**.
-



Errores comunes

- Suspender ISRS antes de las 6 semanas por aparente “falta de efecto”.

- Usar benzodiacepinas como monoterapia o indefinidamente.
 - No educar sobre la latencia de los antidepresivos.
 - Indicar ISRS en dosis demasiado altas desde el inicio (riesgo de activación).
 - No combinar TCC cuando hay recaídas frecuentes.
 - Confundir crisis de pánico con causas médicas sin descartar red flags (ECG, tiroides).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El tratamiento de los trastornos de ansiedad combina **farmacoterapia y TCC** como pilares principales.
2. Los **ISRS** (sertralina, escitalopram, paroxetina) son el **tratamiento farmacológico de elección**; requieren **4–6 semanas** para efecto pleno.
3. Las **benzodiacepinas** se usan solo en **fases iniciales o crisis, ≤4 semanas**, con retiro progresivo.
4. La **TCC** es la **terapia más efectiva y preventiva**; incluye exposición y reestructuración cognitiva.
5. **La combinación ISRS + TCC** mejora la respuesta y previene recaídas.
6. Siempre descartar causas médicas y evaluar comorbilidades depresivas o adictivas.
7. El seguimiento prolongado y la educación del paciente son clave para el éxito terapéutico.